可能可能最可能：

①急性纤维蛋白性心包炎（如急性非特异性心包炎）：**1-3 周感染病史**，随后胸痛（锐痛）、**心包摩擦音**（胸骨左缘 3-4 肋间搔/抓刮音），**心界不大或稍大**

心脏裸区

②渗出性心包炎、心包积液、心脏压塞：呼吸困难、**心界向两侧扩大**、**奇脉**、**Beck 三联征**（心音低弱遥远/血压↓/颈静脉怒张）、Ewart 征、Kussmaul 征

三、检查

1.**超声心动图（首选）**：大量心包积液呈游泳心，吸气时 ttsx 室间隔左移（室间隔抖动征）

吸气时回到右心的血↑→将室间隔推向左室→左心室血↓→搏出量↓;呼气时室间隔就恢复原位

2.心包穿刺

①确诊积液性质（病因诊断）的金标准

②**缓解心脏压塞症状**

③主动脉夹层是心包穿刺的绝对禁忌症

主动脉夹层可以直接破入心包→心包积血,若此时穿刺→心包压力↓→利于主动脉夹层继续出血

3.X 线：心包积液呈**烧瓶心**（心影向两侧显著增大）、特别是**肺野清晰（鉴别左心功能不全）**

虽然心包积液限制了左心和右心但主要突出的是右心的问题。VS 扩心病:左心衰必有肺部问题

若肺"不干净了"不能排除心包积液

4.心电图

①心包积液：QRS 低电压和电交替，窦性心动过速

动用心率储备,维持心输出量

②急性心包炎：除 aVR 和 V_1 导联 ST 段压低以外、其余所有导联 ST 段弓背向下抬高

又可称为凹面向上

我包上岸

VS 急性ST段抬高型心梗:ST段弓背向上抬高









